

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症） Bipolar Disorder				
編號	A31000-Q03-W-L03	制定者	PSY 李家靜	公布日期	102 年 02 月 25 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 2.2 版/12 頁	審查者	曾翊鍵	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解雙相情緒障礙症（雙相症）的定義、症狀、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

雙相情緒障礙症（雙相症），是一種週期性情緒高昂或低落的疾病，病人的情緒起伏較一般人明顯極端且持續時間長，它可以持續數天至數週，甚至更長的時間，症狀及臨床表現為明顯的情緒障礙，此狀況會影響病人的認知、生理功能、人際交往、思考及行為等多方面。最常見的是躁症、鬱症兩種極端的情緒交互出現，昔日又稱為雙極性情感疾病或躁鬱症。依症狀發作的型態，可將雙相情緒障礙症（雙相症）分為：第一型(Bipolar I Disorder)、第二型(Bipolar II Disorder)及循環型情感疾患(Cyclothymic Disorder)。第一型指病患至少有一次完整躁狂發作，第二型指曾經歷至少各一次輕躁及重鬱之發作，循環型則指兩年內經歷過多次輕躁或憂鬱症狀，但症狀嚴重度均未符合完整發作的診斷準則。在流行病學方面，雙相情緒障礙症好發於青少年晚期或青年期，終身盛行率約為2-6%。

（二）症狀

依據DSM-5(2014)，躁症發作會出現有一段明顯的情緒困擾並持續情緒高昂、開闊或易怒，持續至少一週，將近一整天都呈現此種狀態，常見症狀包含：

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	2/12

1. 自尊心膨脹或誇大。
2. 睡眠需求降低（如：只睡 3 小時就覺得休息足夠）。
3. 比平常更多話或滔滔不絕無法停止。
4. 思緒飛躍或主觀感受想法洶湧不止。
5. 報告或觀察到分心（如：注意力很快被不相關的外在刺激而分散）。
6. 增加目標導向的活動（如：無意義的非目標導向行為）。
7. 過度參與可能有痛苦結果的活動（如：不停採購、隨意的性行為或貿然投資）。

鬱症發作在精神狀態可能的表現有下列情況，且整個持續的時間超過兩週以上，出現的症狀需包括抑鬱情緒、幾乎對所有活動失去興趣或愉悅感其中之一：

1. 憂鬱心情幾乎整天都有。
2. 在所有或幾乎的活動，興趣及喜樂都顯著減少。
3. 非處於節食而明顯體重下降或增加；幾乎每天食慾都減少或增加。
4. 幾乎每日失眠或嗜睡。
5. 幾乎每日精神運動激動或遲緩。
6. 幾乎整日疲累或失去活力。
7. 幾乎每日有無價值感、過份而不合宜的罪惡感。
8. 幾乎每日思考活動或專注能力減退、無決斷力。
9. 反覆想到死亡，重複出現無特別計畫的自殺意念，有過自殺嘗試，或已有實行自殺的特別計畫。

（三）常見治療

雙相情緒障礙症患者其自殺風險經常出現在躁鬱混合或交替的時期，也較常出現在女性、年紀輕（例如低於 40 歲）、缺乏社會支持或先前有過自殺行為者身上，在青少年族群，自殺意念或企圖的盛行率甚至超過 50%，在急性治療期以藥物治療為主，而疾病維持期應合併藥物及心理社會介入，實證研究顯示藥物治療輔以心理社會治療介入的成效不斐，可有效降低躁鬱症狀再發作的風險及再住院率，改善病患的治療順從性及持續性。

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	3/12

1. 藥物治療

- (1) 鋰鹽(Lithium)：50-60%的患者有效，但曾多次發病或躁鬱共存、酒精或物質濫用的患者對鋰鹽治療反應較差；藥物副作用：認知障礙、顫抖、疼痛、肌肉無力、體重增加；長期服用鋰鹽可能影響甲狀腺和腎功能。
- (2) 卡馬西平(Carbamazepine, CBZ)：商品名Tegretol，使用此藥需抽血監測藥物濃度及肝臟功能，須留意嚴重藥物副作用可能產生史蒂芬-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)。
- (3) 丙戊酸(Valproic Acid, VPA)：常見商品名Depakine，使用此藥需抽血監測藥物濃度及肝臟功能。
- (4) 拉莫三嗪(Lamotrigine, LTG)：常見商品名Lamictal：使用此藥需抽血監測肝臟功能，須留意可能產生如史蒂芬-強生症候群(Stevens-Johnson Syndrome, SJS)、DRESS症候群(Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms)或中毒性表皮壞死症(toxic epidermal necrolysis, TEN)等嚴重藥物副作用，但上述副作用多出現於開始使用此藥物的第2-8周內出現。
- (5) 抗精神病藥物(antipsychotic drugs)，例如：Risperdal、Geodon、Quetiapine(Seroquel)、Olanzapine、Clozapine。
- (6) 苯二氮平類(Benzodiazepine, BZD)：用於助眠、輔助治療。

2. 心理治療

通常著重於雙相症病患面對負向生活事件或壓力時，經常出現認知偏誤而引發情緒波動所導致的生活調適困擾（因此病通常對生涯規劃有重大影響），提供患者及家屬情緒支持、教育、應對技巧、監控症狀和治療的持續，增加病識感，包括：

- (1) 認知行為治療(cognitive behavior therapy, CBT)
- (2) 以家庭為中心的治療(family-focused therapy, FFT)
- (3) 人際社會節奏治療(interpersonal and social rhythm therapy, IPSRT)
- (4) 心理衛生教育(psychoeducation, PE)

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	4/12

（四）護理問題

1. 易自我傷害或暴力／抑鬱。
2. 易對別人傷害或暴力／躁症。
3. 缺乏營養／抑鬱。
4. 排便異常：便秘／腸胃活動減弱。
5. 睡眠障礙／躁鬱反應。
6. 自我照顧尋求協助：沐浴/衛生／抑鬱。
7. 失去因應能力／心理資源不足（如：對自己有過度負向的看法、無助）。

（五）護理措施

1. 易自我傷害或暴力／抑鬱
 - (1) 提供治療性環境，色調宜明亮、勿吵雜，擺設簡單且通風。
 - (2) 將病人置於人多的房間或近護理站，必要時需隨時有人陪伴，可聯絡當事人的家屬或其親近的人來院協助或請看護 24 小時照顧。
 - (3) 評估環境安全性，不定時的安檢，將可能的危險物品移走，維持一個安全的環境。
 - (4) 觀察與記錄病人言行及自傷行為的先兆（尤其以憂鬱症恢復期之初期 3 至 6 個月），特別是在夜班、假日及交班時段，須特別的注意。
 - (5) 觀察並執行藥物確實服下，以防藏藥及儲藥。
 - (6) 定時個別會談表達關心，傾聽病人的感受與心聲，鼓勵表達感受不要給予個人的意見或批判，給予發洩的機會；隨時評估病人的自殺意念強度、是否有自殺計畫等，並密切觀察之。
 - (7) 衛教情緒管理技巧，以健康、不傷害自己的方式發洩或放鬆情緒的情緒管理（例如：運動、打枕頭、扭毛巾、撕紙條、提供保護室等）。
2. 易對別人傷害或暴力／躁症
 - (1) 引導思考其他的選擇或替代方案，以減少暴力之產生，如：深呼吸可放鬆並減輕焦慮；運動、散步或提供保護室給予大喊、搥打海綿牆、以發洩情

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	5/12

緒。

- (2) 藥物衛教服用藥物的重要性，視需要時給予依臨時醫囑藥物幫助控制行為。
- (3) 親視服藥並觀察是否出現藥物副作用。
- (4) 評值目前的暴力危險因子，如：年輕、男性、暴力史、壓力、物質濫用史等。
- (5) 引導表達對此事件之感受，對其不合現實的認知及被害感受需立即澄清。
- (6) 監測瀕臨暴力發作的症狀（如：握拳、說話音量大、咬牙切齒等）勿單獨接觸正憤怒中的病人、注意安全距離（2-3 呎）、勿觸摸病人，呼叫尋求其他工作人員支援。
- (7) 聯絡醫師評估約束或保護隔離的必要性，約束病人的身體以控制暴力行為，防止進一步的傷害。
- (8) 提供一個安靜、清爽的環境空間，以減少環境刺激。
- (9) 以冷靜、平穩的語氣向病人解釋我們做了什麼及為何要如此做。
- (10) 監測藥物的副作用及病人的精神及情緒狀態。
- (11) 依醫囑給藥、記錄並填寫隔離約束治療單。
- (12) 保護約束過程要提供充足的水分、營養及個人衛生。
- (13) 運用會談了解病人的需要及感受，教導質疑自己使用暴力行為之情況提供心理治療措施，以協助增加對行為的控制，如：承擔自己行為的責任、獲得自我控制感及能表達正向感受等。
- (14) 提供教育性措施，以改善壓力、易受傷性及過度敏感性如：減輕壓力的方法、人際與社交的技巧及必須遵從治療等。

3. 缺乏營養／抑鬱

- (1) 了解食慾下降或拒食原因，協助澄清解釋並鼓勵進食。
- (2) 以少量多餐方式供餐，隨時給予提供飲料與點心，並給予充足時間進食，必要時請家屬幫忙病人準備喜愛的食物或協助餵食。
- (3) 選擇易消化及咀嚼之高熱量、高蛋白及高維生素食物。
- (4) 觀察進食情形注意並必要時記錄飲食狀況及評估實際營養需求及體重的變

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	6/12

化提醒飲水，以防止脫水。

- (5) 身體疾病獲得改善後觀察並記錄飲食狀況及評估實際營養需求；必要時可記錄輸出入量及體重的變化，以供了解與參考。
- (6) 有明顯的飲食改善時，給予支持及正向的鼓勵稱讚。

4. 排便異常：便秘／腸胃活動減弱

- (1) 鼓勵多攝取高纖維素食物，如：穀類食品、麵包、水果、蔬菜等，要注意當在增加食用高纖維食物的同時，也須增加水份或流質的攝取量（每天應飲用約 1500-2000cc），以免便秘加劇。
- (2) 經常運動是其中一種可以預防及治療便秘的方法，故宜鼓勵病人多參與活動，增加活動量適合體能的運動如跑步、步行等，都可以幫助預防及治療便秘。
- (3) 排便訓練：習慣餐後上廁所、每天定時上廁所（例如在早上）、使用合適高度的坐廁、坐在坐廁後，雙腳平放在地面或小凳子上，身體微微向前傾以放鬆盆腔肌肉，可免排便過程太過用力。
- (4) 超過 3 天未排便或有不舒服之主訴時，可依醫囑給藥（MgO、Dulcolax、Sennapur 等）或灌腸。

5. 睡眠障礙／躁鬱症狀

- (1) 了解過去及近日之睡眠形態及作息時間，每 30 分觀察並記錄睡眠型態，監測影響睡眠的因素（例如焦慮、擔憂或疼痛）。
- (2) 白天盡量減少躺床機會或時間，包含白天的午休、小睡片刻或打瞌睡都應避免，鼓勵多下床活動或協助安排活動參與，以免影響夜眠。
- (3) 為了避免夜間頻尿而起床上廁所，影響到睡眠，最好晚餐後少喝水及飲料。
- (4) 睡前可做溫和及放鬆身心之活動，如：肌肉鬆弛及深呼吸運動。
- (5) 觀察走路步態避免跌倒，必要時給予帶領（扶持）至單位，協助躺床，若拒絕回房，但仍呈倦怠狀，則協助必要時暫約束於床上，熟睡後再解除約束，過程需向病人說明。

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	7/12

(6) 提供睡眠衛生教育，建立良好睡眠習慣及品質。若於半夜醒來，鼓勵病人再回房入睡；若主訴已睡飽，在不干擾病房安寧下，允許病人做私人的事，如看報、靜坐等。

(7) 當有入睡困難（服完睡前藥後 2 小時仍未能入睡）或睡眠中斷再入睡困難時（夜醒 1 小時仍未能再入睡），可連絡值班醫師評估依醫囑給藥。

6. 自我照顧尋求協助：沐浴/衛生／抑鬱

- (1) 與病人討論以了解個人衛生執行狀況，並約定每天沐浴一次。
- (2) 協助將日常個人衛生用品簡化並放置固定位置，以方便取用，於沐浴時間提醒病人自行或協助準備沐浴用品。
- (3) 初期要耐心引導、協助或督促完成盥洗、沐浴、更換乾淨衣褲；評估其執行能力，如需完全協助時：男病人：請醫佐協助沐浴（護理人員請協助準備用品）、女病人：由護理人員協助；需半協助時，於沐浴時間提醒病人並與其一同準備用物，於浴室觀察其執行情形。
- (4) 鼓勵病人在能力範圍內盡可能自行執行衛生活動；完成沐浴時帶病人至鏡前鼓勵注意外觀及儀容整理（女則注意頭髮清潔、梳理，男則需注意刮鬍子）等。
- (5) 當病人有能力獨立執行時，給予足夠的時間使病人在無人的協助下盡其最大的能力完成。
- (6) 以漸進式方式讓病人學習獨立完成盥洗、沐浴及儀容整理，增加病人對自己的重視與興趣。
- (7) 對於病人儀表改變之進步，須具體將改變之處指出並給予口頭的鼓勵與肯定。

7. 失去因應能力／心理資源不足（如：對自己有過度負向的看法、無助）

- (1) 以簡短、頻繁接觸病人，建立治療性人際關係。
- (2) 適時並定期提供人、事、物等周遭訊息。
- (3) 以和善、真誠、支持、耐心和了解的態度協助病人，使之感受到自己是被接受的。

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	8/12

- (4) 會談過程應鼓勵並協助病人談論其想法和感覺，使之感受到被尊重並學習自我表達；當出現不合理信念時，應予澄清觀念，以防因個人連續的挫敗經驗，而致想法偏差，肯定其優點與過去成就，明白指出進步之處，增加對自我的了解，以提昇自我價值。
- (5) 鼓勵病人了解自己的想法和感受，主張自己的權利。因此互動初期可暫時協助病人做決定，減輕病人的負擔，再慢慢的讓病人學習自己獨立做決定，協助重建及學習面對處理危機及負責任的能力。
- (6) 鼓勵病人覺察存在於自身的正向資源，並展現彈性、復原的過程，及發展希望、樂觀等正向情緒，在面臨危機或是壓力情結時，可以保持良好的功能與自我調整，更發展出健康的因應行為。

（六）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

五、流程圖

（略）

六、參考資料

- （一）許佳茵、楊秋月(2019)·運用人際社會節奏治療於一位第一型雙相情緒障礙症躁期發作病人之護理經驗·精神衛生護理雜誌，14(1)，23-33。
- （二）謝佳容(2020)·雙相情緒障礙症及憂鬱症的護理·於蕭淑貞總校閱，精神科護理學（五版，296-331 頁）·新北市：新文京開發。
- （三）American Psychological Association. (2014)·DSM-5 精神疾病診斷準則手冊（臺灣精神醫學會譯）·台北市：合記圖書出版社。（原著出版於 2013）

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	9/12

七、附件

（略）

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	10/12

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.02.25	1.0	新制定	102 年 02 月 25 日護理部照護標準委員會通過；102 年 02 月 25 日公布
102.08.31	1.1	說明內容部份修正	102 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
103.06.30	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
103.08.31	1.2	1. 說明內容部份修辭 2. 參考資料文獻部份內容更新	103 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
104.08.31	1.3	1. 第三項第（一）、（三）目部份內容新增 2. 第六項參考資料增刪及修訂 APA 格式	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	1.4	1. 第三項第（一）、（二）部份內容增刪。 2. 參考文獻新增於內文。 3. 第六項參考資料增刪及修訂。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	1.5	1. 第三項第（三）、（五）目部分內容增刪。 2. 第六項參考資料增刪及修訂。	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
108.09.23	1.6	1. 主題名稱：疾病診斷名稱修訂。 2. 第二項新增（含中興分院）。 3. 第三項第一、三目說明內容修訂及參考文獻新增於內文。 4. 第三項第六日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 5. 第六項參考資料新增。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	1.7	1. 主題名稱刪除情感性疾病，修訂為雙相情緒障礙症（雙相症）。 2. 第一項刪除情感性疾病，修訂為雙相情緒障礙症（雙相症）。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	11/12

修正日期	版本	修正說明	備註
		3. 第三項第一、二、三、五目內容修訂及參考文獻增刪。 4. 第六項參考資料部分增刪。	08 月 18 日督導會議通過公布。
110.09.07	1.8	參考文獻於內文引用呈現方式，依 APA 格式第七版規範修訂	110 年 08 月 05 日照護標準組會議通過； 110 年 08 月 11 日護理長會議通過；110 年 09 月 07 日督導會議通過公布。
111.09.06	1.9	1. 第三項第一、二、三目說明內容修訂。 2. 第三項第四、五目護理問題修正。 3. 第六項參考文獻部份增刪及更新。 4. 內文參考文獻統一刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.09.05	2.0	第六項參考資料部份刪除。	112 年 08 月 03 日照護標準組會議通過； 112 年 08 月 09 日護理長會議通過；112 年 09 月 05 日督導會議通過公布。
113.09.03	2.1	1. 第三項第三目說明內容文字修訂。 2. 刪除第三項第三目之 1。 3. 第三項第五目說明內容文字修訂。 4. 第六項參考資料部份刪除。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過； 113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.10.08	2.2	1. 第三項第三目之 1 說明內容修訂。	114 年 08 月 07 日照護標準組會議通過； 114 年 09 月 10 日護理長會議通過；114 年 10 月 08 日督導會議通過公布。

主題名稱	雙相情緒障礙症（雙相症）	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-L03	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	12/12

修正日期	版本	修正說明	備註